EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 79964
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 03-03-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: EVA DEL CARMEN CONTRERAS ABARZUA			RUN	: 4.639.750-9
F.Nac	: 09-03-1941	Edad	: 82 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: paque norte			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA D	Teléfono	: 990152191		
Fecha Ingreso	: 2024-03-02	Fecha Egreso	: 03-03-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-Infeccion x SARS COV 2
2-antecedente de Transplante pulmonar, HTA sistemica

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente refiere inicio de sintomatología hace 2 días+ presentando accesos de tos intermitente leve a moderada, expectoración no efectiva, además de aumento de temperatura corporal, CEG, mialgia generalizada, y dificultad respiratoria a leves esfuerzos. Difícil anamnesis para momento de ingreso a servicio. Acude a SU presentando síntomas descritos previamente, por lo que se toman exámenes de laboratorio con escasa elevación de parámetros inflamatorios, hiponatremia, además de test positivo para SARSCOV2. Paciente ingresa en contexto de insuficiencia respiratoria aguda, sin embargo a la evaluacion paciente hemodinamicamente estable, con adecuada mecanica ventilatoria normosaturacion ambiental. se evalua Rx torax con patron intersticial difuso en pulmon izquierdo secundario a FPI como antecedente y Hemitorax derecho sin focos de condensacion. se evaluan laboratorios con parametros inflamatorios discretamtente altos por lo que se plantea Hospitalizacion domiciliaria para apoyo Kinesico.

PLAN DE MANEJO:

seguimiento en Hospitalizacion domiciliaria.

INDICACIONES AL ALTA

1. 1-Regimen diabetico

2. 2-omeprazol 20mg via oral una vez al dia
3. 3-Paracetamol 500mg via oral c/8h SOS fiebre
4. 4-azitromicina 500mg via oral una vez al dia por 4 dias
5. 5-cortik 4mg via oral cada 12 horas por 7 dias
6. 6-Bromuro ipatropio 4 puff c/6h x 7 dias
7. 7-Budesonida 2 puff c/12h x 7 dias
8. 8-Mantener tratamiento habitual de base
9. 9-KNT respiratoria
10. 10-En caso de quiebre clinico Derivar al SU HSC .
11. 11-Cumplir aislamiento segun protcolo IAAS.

jesus luis antonio perez lozada
MEDICO TRATANTE
26918952-5

JEFE SERVICIO